



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN HIV/AIDS
RS PRIMA HUSADA**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Nomor:

Tentang Pedoman Pelayanan HIV/AIDS

Disusun oleh :

Penanggung jawab

(dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD)

Disetujui oleh :
Authorized Person

(Dr. dr. Aslichah M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pedoman Pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit ini dapat disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan bagi pasien HIV/AIDS.

HIV/AIDS masih menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan, yang memerlukan penanganan secara menyeluruh mulai dari deteksi dini, diagnosis, terapi antiretroviral (ART), pengelolaan infeksi oportunistik, hingga dukungan psikososial dan pencegahan penularan. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, tidak diskriminatif, serta menjamin kerahasiaan status kesehatan pasien.

Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan HIV/AIDS sesuai standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelayanan HIV/AIDS di rumah sakit dapat terlaksana secara sistematis, terkoordinasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu serta keselamatan pasien.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi landasan dalam upaya pengendalian HIV/AIDS serta peningkatan kualitas hidup pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Pasuruan, 1 November 2025
Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PELAYANAN TIM HIV/AIDS

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP
2. Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

PELAKSANA

1. dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD
2. Vira Agustin Sintia Putri, A.md Kep
3. Roikhatul Jannah., S.Kep.,Ns
4. Ayu Indra Irmia, A.md. Farm
5. Anita Suprihatinigrum., Amd. Kes
6. Novi Hidayati, S.Tr.Kes

DAFTAR ISI

SAMPUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

TIM PENYUSUN..... iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

PERATURAN DIREKTUR..... vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan..... 1

 1.3 Ruang Lingkup 3

 1.4 Batas Operasional..... 3

BAB II STANDAR KETENAGAAN..... 4

 2.1 Struktur Organisasi Tim Pelayanan HIV AIDS 4

 2.2 Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang 4

BAB III STANDAR FASILITAS 9

 3.1 Ruang Pelayanan HIV/AIDS..... 9

 3.2 Ruang Konseling..... 9

 3.3 Ruang Pemeriksaan dan Tindakan 10

 3.4 Fasilitas Laboratorium 11

 3.5 Fasilitas Farmasi 12

 3.6 Sarana Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 12

 3.7 Peralatan Medis 13

 3.8 Sistem Informasi dan Rekam Medis 14

 3.9 Sarana Edukasi..... 14

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN 16

 4.1 Program Penanggulangan HIV..... 17

 4.2 Rujukan HIV/AIDS..... 17

 4.3 Pelayanan PITC dan PMTC 18

 4.4 Pelayanan ODHA..... 19

 4.5 Penyediaan ARV 20

 4.6 Pemantauan dan Evaluasi Program Penanggulangan HIV AIDS 22

BAB V LOGISTIK 24

 5.1 Perencanaan Kebutuhan Logistik 24

 5.2 Pengadaan Logistik..... 25

 5.3 Penerimaan dan Verifikasi 25

 5.4 Penyimpanan 25

 5.5 Distribusi dan Penyaluran 26

 5.6 Penggunaan dan Pengendalian 27

 5.7 Pengelolaan Obat Kedaluwarsa dan Limbah..... 28

BAB VI KESELAMATAN PASIEN 29

 6.1 Ketentuan Umum 29

 6.2 Sasaran Keselamatan Pasien 29

 6.3 Penerapan Keselamatan dalam Pelayanan HIV/AIDS..... 29

 6.4 Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien 29

BAB VII KESELAMATAN KERJA 30

 7.1 Identifikasi Risiko Kerja 30

 7.2 Pencegahan dan Pengendalian Risiko 30

 7.3 Penanganan Paparan..... 30

 7.4 Pelatihan dan Edukasi Petugas..... 31

 7.5 Pemeriksaan Kesehatan Petugas 31

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU..... 32

 8.1 Indikator Mutu Pelayanan HIV/AIDS..... 32

 8.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu 32

 8.3 Pengumpulan dan Analisa Data 32

	8.4 Audit dan Evaluasi	32
	8.5 Tindak Lanjut Perbaikan.....	32
BAB IX	PENUTUP.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Struktur Organisasi Tim Pelayanan HIV/AIDS 4

Tabel 8.1.1 Indikator Mutu Pelayanan HIV/AIDS..... 32



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 951.6/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN GERIATRI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan HIV/AIDS termasuk Pelayanan Skrining HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang professional, terstandart, terintegritas dan bermutu tinggi;
- b. bahwa agar pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang pedoman Pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan HIV/AIDS.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No 23 tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS dan Infeksi Menular Seksual;
4. Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
5. Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024;
6. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada SukorejoPengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN HIV/AIDS RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara



- paripurna, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*;
 - (3) *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV;
 - (4) Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus, dan oral/dengan mulut;
 - (5) Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk:
 - a. menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian;
 - b. membatasi penularan HIV, AIDS, dan IMS agar tidak meluas;
 - c. mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya;
 - (6) Orang Dengan HIV yang selanjutnya disingkat ODHIV adalah orang yang terinfeksi HIV;
 - (7) Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang diberikan untuk pengobatan infeksi HIV untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perkembangan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi;
 - (8) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II STANDAR KETENAGAAN

Pasal 2

- (1) Direktur rumah sakit menetapkan struktur organisasi pelayanan HIV/AIDS yang sekurang-kurangnya terdiri dari penanggung jawab program, tim pelayanan klinis, tim penunjang, serta tim administrasi dan pelaporan;
- (2) Penanggung jawab program pelayanan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s merupakan tenaga medis yang kompeten dan memiliki kewenangan klinis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Tim pelayanan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga kesehatan multidisiplin yang meliputi dokter, perawat, tenaga laboratorium, apoteker, dan tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan pelayanan;
- (4) Tim penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unit laboratorium, farmasi, rekam medis, konselor HIV, serta unit lain yang mendukung pelayanan HIV/AIDS secara komprehensif;
- (5) Rumah sakit menyediakan layanan HIV/AIDS secara



komprehensif yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan, deteksi dini, diagnosis, pengobatan, perawatan, dukungan, serta rehabilitasi;

- (6) Dalam pelaksanaan pelayanan HIV/AIDS, rumah sakit menjamin koordinasi dan komunikasi yang efektif antar unit kerja serta dengan jejaring pelayanan kesehatan lain, termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan;
- (7) Rumah sakit menetapkan mekanisme rujukan internal dan eksternal untuk menjamin kesinambungan pelayanan pasien HIV/AIDS;
- (8) Seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan HIV/AIDS mendapatkan pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan yang berlaku.

BAB III STANDAR FASILITAS

Pasal 3

- (1) Rumah sakit menyediakan fasilitas pelayanan HIV/AIDS yang memenuhi standar keselamatan, mutu, dan kelayakan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Fasilitas pelayanan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin privasi, kerahasiaan, kenyamanan, dan keamanan pasien dalam seluruh proses pelayanan;
- (3) Rumah sakit menyediakan ruang pelayanan khusus atau terintegrasi untuk pelayanan HIV/AIDS yang meliputi:
 - a. Ruang konseling pra dan pasca tes HIV;
 - b. Ruang pemeriksaan dan tindakan medis;
 - c. Ruang pengambilan sampel;
 - d. Ruang pelayanan terapi dan tindak lanjut;
- (4) Ruang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dirancang untuk menjamin kerahasiaan informasi pasien dan memberikan kenyamanan bagi pasien dan konselor;
- (5) Rumah sakit menyediakan fasilitas laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan terkait HIV/AIDS sesuai dengan tingkat kemampuan rumah sakit, termasuk pemeriksaan skrining, diagnostik, dan pemantauan terapi;
- (6) Dalam hal pemeriksaan laboratorium tidak dapat dilakukan secara internal, rumah sakit menjalin kerja sama dengan laboratorium rujukan yang terakreditasi;
- (7) Rumah sakit menyediakan fasilitas farmasi yang menjamin ketersediaan, penyimpanan, dan distribusi obat antiretroviral (ARV) serta obat pendukung lainnya sesuai dengan standar yang berlaku;
- (8) Penyimpanan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memenuhi persyaratan suhu, keamanan, serta sistem pengendalian mutu obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Rumah sakit wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) yang memadai,



termasuk alat pelindung diri, fasilitas cuci tangan, serta sistem pengelolaan limbah medis.

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

Pasal 4 Program Penanggulangan HIV

- (1) Rumah sakit menyelenggarakan program penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan sesuai standar akreditasi dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Program penanggulangan HIV/AIDS meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative;
- (3) Rumah sakit melaksanakan layanan pencegahan meliputi edukasi, skrining, konseling, serta upaya pencegahan penularan HIV;
- (4) Rumah sakit menyediakan pelayanan diagnosis, pengobatan dengan terapi antiretroviral (ARV), serta pemantauan klinis pasien HIV/AIDS;
- (5) Rumah sakit memberikan dukungan, perawatan, dan rehabilitasi bagi pasien HIV/AIDS secara berkesinambungan;
- (6) Rumah sakit menjalin koordinasi dan jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain serta program pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS;
- (7) Rumah sakit wajib melaksanakan pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi program penanggulangan HIV/AIDS secara berkala.

Pasal 5 Rujukan HIV/AIDS

- (1) Rumah sakit menyelenggarakan sistem rujukan pelayanan HIV/AIDS yang terintegrasi, berkesinambungan, dan sesuai dengan standar akreditasi serta peraturan perundang-undangan;
- (2) Rujukan dilakukan berdasarkan indikasi medis, kebutuhan pelayanan, dan kemampuan fasilitas pelayanan Kesehatan;
- (3) Rumah sakit menjamin kesiapan rujukan internal antar unit dan rujukan eksternal ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu;
- (4) Proses rujukan harus dilengkapi dengan informasi medis yang lengkap, jelas, dan menjaga kerahasiaan status HIV pasien;
- (5) Rumah sakit memastikan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara fasilitas pengirim dan penerima rujukan;
- (6) Rumah sakit menjamin kesinambungan pelayanan, termasuk tindak lanjut pasien setelah dirujuk atau kembali dirujuk;
- (7) Rumah sakit melakukan pencatatan, pelaporan, serta evaluasi pelaksanaan rujukan HIV/AIDS secara berkala.



Pasal 6

Pelayanan PITC dan PMTC

- (1) Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan *Provider Initiated Testing and Counseling* (PITC) dan *Prevention of Mother to Child Transmission* (PMTCT) secara terintegrasi sesuai standar akreditasi dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelayanan PITC dilaksanakan pada pasien dengan indikasi medis atau kelompok berisiko melalui penawaran tes HIV secara aktif disertai konseling pra dan pasca tes;
- (3) Pelayanan PMTCT dilaksanakan pada ibu hamil, bersalin, dan menyusui untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak melalui skrining, terapi antiretroviral (ARV), serta tatalaksana yang sesuai;
- (4) Rumah sakit menjamin persetujuan tindakan (*informed consent*), kerahasiaan hasil pemeriksaan, serta pelayanan tanpa diskriminasi;
- (5) Rumah sakit menjamin ketersediaan sumber daya, sarana, dan logistik untuk mendukung pelayanan PITC dan PMTCT;
- (6) Rumah sakit melakukan pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan PITC dan PMTCT secara berkala.

Pasal 7

Pelayanan ODHA

- (1) Rumah sakit memberikan pelayanan kepada Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) secara komprehensif, berkesinambungan, dan sesuai standar akreditasi serta peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelayanan ODHA meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk terapi antiretroviral (ARV) dan penatalaksanaan infeksi oportunistik;
- (3) Rumah sakit menjamin pelayanan yang bermutu, aman, serta berorientasi pada kebutuhan pasien (*patient centered care*);
- (4) Rumah sakit menjaga kerahasiaan status HIV pasien dan memberikan pelayanan tanpa stigma dan diskriminasi;
- (5) Rumah sakit memberikan edukasi, konseling, dan dukungan untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan dan kualitas hidup ODHA;
- (6) Rumah sakit menjamin kesinambungan pelayanan melalui koordinasi antar unit dan jejaring rujukan;
- (7) Rumah sakit melakukan pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelayanan ODHA secara berkala.

Pasal 8

Penyediaan ARV

- (1) Rumah sakit menjamin ketersediaan obat antiretroviral (ARV) secara cukup, berkesinambungan, dan sesuai standar akreditasi serta peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyediaan ARV dilaksanakan melalui perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi sesuai ketentuan yang berlaku;



- (3) Rumah sakit memastikan mutu, keamanan, dan masa kedaluwarsa ARV melalui sistem pengelolaan logistik yang tepat;
- (4) Penyimpanan ARV harus memenuhi persyaratan suhu, keamanan, serta menerapkan prinsip FIFO dan/atau FEFO;
- (5) Pendistribusian ARV dilakukan tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat pasien;
- (6) Rumah sakit mencegah terjadinya kekosongan stok ARV melalui monitoring dan evaluasi persediaan secara berkala.

Pasal 9

Pemantauan dan Evaluasi Program Penanggulangan HIV/AIDS

- (1) Rumah sakit melaksanakan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan HIV/AIDS secara berkala sesuai standar akreditasi dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui pengumpulan, analisis, dan pelaporan data program secara akurat dan berkesinambungan;
- (3) Rumah sakit menetapkan indikator kinerja program HIV/AIDS yang terukur sebagai dasar penilaian keberhasilan program;
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk perbaikan mutu pelayanan, peningkatan kinerja, dan pengambilan Keputusan;
- (5) Rumah sakit melakukan pelaporan program HIV/AIDS kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Rumah sakit melibatkan unit terkait dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi secara terkoordinasi.

BAB V LOGISTIK

Pasal 10

- (1) Rumah sakit menyelenggarakan pengelolaan logistik pelayanan HIV/AIDS secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengelolaan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemantauan, serta pengendalian persediaan logistik pelayanan HIV/AIDS;
- (3) Rumah sakit menjamin ketersediaan logistik pelayanan HIV/AIDS secara berkesinambungan, meliputi:
 - a. Obat antiretroviral (ARV);
 - b. Obat untuk infeksi oportunistik dan komorbid;
 - c. Reagen dan bahan habis pakai laboratorium;
 - d. Alat kesehatan;
 - e. Bahan pendukung pelayanan lainnya
- (4) Perencanaan kebutuhan logistik dilakukan secara berkala berdasarkan data pemakaian, jumlah pasien, pola penyakit, serta proyeksi kebutuhan pelayanan;
- (5) Pengadaan logistik dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang



- berlaku dan menjamin mutu, keamanan, serta keabsahan produk;
- (6) Rumah sakit wajib memastikan bahwa seluruh logistik yang diterima telah melalui proses verifikasi mutu, jumlah, dan masa kedaluwarsa sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - (7) Penyimpanan logistik harus memenuhi persyaratan sesuai karakteristik masing-masing barang, termasuk pengaturan suhu, kelembaban, keamanan, serta sistem penataan yang menjamin prinsip First Expired First Out (FEFO) dan/atau First In First Out (FIFO);
 - (8) Rumah sakit wajib menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan logistik yang akurat, terintegrasi, dan dapat ditelusuri setiap saat;
 - (9) Pendistribusian logistik dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat sasaran untuk menjamin kesinambungan pelayanan pasien HIV/AIDS;
 - (10) Rumah sakit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan logistik secara berkala untuk mencegah kekosongan, kelebihan stok, serta penyalahgunaan;
 - (11) Logistik yang rusak, kedaluwarsa, atau tidak memenuhi standar wajib dikelola dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KSELAMATAN PASIEN

Pasal 11

- (1) Rumah sakit menjamin keselamatan pasien dalam seluruh pelayanan HIV/AIDS sesuai standar akreditasi dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan keselamatan pasien dilakukan dengan menerapkan sasaran keselamatan pasien meliputi: identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan penggunaan obat, ketepatan tindakan, pencegahan infeksi, dan pencegahan risiko jatuh;
- (3) Rumah sakit menjamin keamanan terapi antiretroviral (ARV) melalui verifikasi, pemantauan efek samping, dan edukasi kepatuhan pasien;
- (4) Rumah sakit menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dalam seluruh pelayanan HIV/AIDS;
- (5) Rumah sakit menjaga kerahasiaan status HIV pasien dan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi;
- (6) Rumah sakit menyediakan sistem pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien;
- (7) Rumah sakit melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

BAB VII KESELAMATAN KERJA

Pasal 12

- (1) Rumah sakit menjamin keselamatan kerja bagi seluruh tenaga kesehatan dan nonkesehatan dalam pelayanan HIV/AIDS sesuai



- standar akreditasi dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keselamatan kerja dilaksanakan melalui penerapan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - (3) Rumah sakit menyediakan dan memastikan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan risiko kerja;
 - (4) Rumah sakit menerapkan prosedur pencegahan paparan, termasuk penanganan tertusuk jarum dan paparan bahan infeksius;
 - (5) Rumah sakit menyediakan tata laksana penanganan pasca paparan (post exposure prophylaxis/PEP) secara cepat dan tepat;
 - (6) Rumah sakit memberikan pelatihan dan edukasi keselamatan kerja secara berkala kepada seluruh petugas;
 - (7) Rumah sakit menyediakan sistem pelaporan dan tindak lanjut kejadian kecelakaan kerja;
 - (8) Rumah sakit melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin keselamatan kerja dan peningkatan mutu pelayanan.

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU

Pasal 13

- (1) Rumah sakit melaksanakan pengendalian mutu pelayanan HIV/AIDS secara berkelanjutan sesuai standar akreditasi dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengendalian mutu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan pelayanan;
- (3) Rumah sakit menetapkan indikator mutu pelayanan HIV/AIDS yang terukur dan dilakukan pemantauan secara berkala;
- (4) Rumah sakit melakukan audit klinis dan evaluasi kepatuhan terhadap standar prosedur operasional pelayanan HIV/AIDS;
- (5) Rumah sakit melakukan analisis dan tindak lanjut terhadap hasil indikator mutu dan insiden untuk peningkatan pelayanan;
- (6) Rumah sakit melibatkan seluruh unit terkait dalam kegiatan peningkatan mutu pelayanan HIV/AIDS;
- (7) Rumah sakit melakukan pelaporan dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

BAB IX PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo ini mulai berlaku, peraturan direktur rumah sakit prima husada nomor tentang Pedoman Pelayanan HIV AIDS dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 15

Peraturan direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasuruan, 1 November 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 951.6/RSPHS/I-
PER/DIR/XI/2025
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
HIV/AIDS RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA

PEDOMAN PELAYANAN HIV/AIDS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan infeksi menular seksual (IMS) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia dan Indonesia, dan meluas hingga masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Orang yang terinfeksi HIV (ODHIV) sampai saat ini masih mengalami stigma, baik di keluarga, petugas kesehatan, dan masyarakat umum. Stigma terjadi karena kurangnya pengetahuan dan adanya pemahaman yang keliru terhadap HIV dan Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS).

Infeksi menular seksual merupakan salah satu di antara lima kategori penyakit terbanyak yang menyebabkan orang dewasa mencari di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah. Penyakit IMS menyebabkan masalah kesehatan seksual dan reproduksi, antara lain kematian janin dan bayi baru lahir (neonatal) akibat sifilis kongenital, infertilitas akibat infeksi klamidia (klamidiosis) dan gonore yang tidak diobati, serta pengobatan berkembangnya gonore resisten obat antibiotika. Di samping itu, IMS juga menjadi beban anggaran nasional dan rumah tangga.

Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS memiliki manfaat kesehatan masyarakat yang luas dan berkontribusi pada kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030, terkait dengan mengakhiri kematian yang dapat dicegah dari anak berusia di bawah 5 tahun, memerangi penyakit menular (SDG 3.3), termasuk HIV, AIDS, IMS, dan menyediakan akses universal untuk perawatan kesehatan reproduksi (SDG 3.7).

Pemerintah berkomitmen untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030, termasuk eliminasi penularan HIV dari ibu ke anak dan eliminasi sifilis kongenital. Komitmen tersebut ditandai dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan dan peningkatan pendanaan. Dalam upaya mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030 dan eliminasi IMS, beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain:

1. Cakupan penemuan kasus HIV belum mencapai target.
2. Akses dan cakupan ODHIV pada pengobatan ARV dan keberlanjutan pengobatan perlu ditingkatkan.
3. Akses ODHIV pada pemeriksaan viral load HIV perlu ditingkatkan/ diperluas.
4. Akses ODHIV pada terapi pencegahan TBC dan infeksi oportunistik perlu ditingkatkan.
5. Cakupan pencegahan HIV dan Sifilis dari ibu ke anak perlu ditingkatkan, khususnya akses deteksi dini HIV dan Sifilis, pengobatan ARV bagi ODHIV

hamil dan pencegahan bagi anaknya.

6. Kurangnya penyediaan informasi dan penerapan strategi komunikasi dan edukasi untuk perubahan perilaku pada populasi kunci, dan didukung dengan penyediaan akses masyarakat pada deteksi dini/ skrining IMS dan HIV, dan stigma dan diskriminasi yang masih dialami ODHIV.

Pemerintah melakukan upaya percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS, mulai dari :

1. Peningkatan akses dan penambahan jumlah layanan pencegahan, tes, dan pengobatan HIV dan IMS, termasuk pemenuhan kebutuhan logistik obat dan non-obat.
2. Eliminasi penularan infeksi HIV, sifilis dan bersamaan dengan hepatitis B dari ibu ke anak (tripel eliminasi).
3. Pengembangan kapasitas laboratorium kesehatan untuk pemeriksaan HIV, AIDS, dan IMS, serta perbaikan dan inovasi termasuk penggunaan teknologi dalam penyediaan data dan informasi serta pemantauan pelaksanaan kegiatan penanggulangan. Karena diperlukan regulasi dan penyesuaian pedoman yang ada dengan rekomendasi global, pendekatan kesehatan masyarakat dan perkembangan ilmu kedokteran, yang telah terbukti efektif untuk Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS, maka disusunlah Pedoman, Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS yang lebih komprehensif.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan acuan dan pedoman bagi rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan HIV/AIDS yang terstandar, terintegrasi, bermutu, dan berkesinambungan sesuai dengan standar akreditasi dan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Umum

Meningkatkan mutu pelayanan HIV/AIDS di rumah sakit yang aman, efektif, dan berorientasi pada pasien guna mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif.

3. Tujuan Khusus

- a. Menjamin terselenggaranya pelayanan HIV/AIDS yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- b. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan logistik termasuk obat antiretroviral (ARV).
- c. Meningkatkan deteksi dini melalui layanan konseling dan tes HIV (PITC).
- d. Mencegah penularan HIV, termasuk dari ibu ke anak (PMTCT).
- e. Menjamin keselamatan pasien dan keselamatan kerja tenaga kesehatan.
- f. Menjamin pelayanan tanpa stigma dan diskriminasi serta menjaga kerahasiaan status pasien.
- g. Meningkatkan kepatuhan pengobatan dan kualitas hidup Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- h. Menjamin kesinambungan pelayanan melalui sistem rujukan yang efektif.
- i. Meningkatkan pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi program HIV/AIDS.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pelayanan HIV/AIDS di rumah sakit meliputi:

1. Pengorganisasian pelayanan HIV/AIDS.
2. Pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
3. Pelayanan konseling dan tes HIV (PITC) serta pencegahan penularan ibu ke anak (PMTCT).
4. Pelayanan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), termasuk terapi antiretroviral (ARV) dan penatalaksanaan infeksi oportunistik.
5. Sistem rujukan internal dan eksternal.
6. Penyediaan dan pengelolaan logistik, termasuk obat ARV dan bahan medis habis pakai.
7. Standar fasilitas dan sarana prasarana pelayanan.
8. Sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi petugas.
9. Keselamatan pasien dan keselamatan kerja (K3) serta pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI).
10. Pengendalian mutu pelayanan.
11. Pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi program HIV/AIDS.

1.4 BATASAN OPERASIONAL

1. Pelayanan HIV/AIDS adalah rangkaian pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi pasien dengan HIV/AIDS di rumah sakit.
2. Pasien HIV/AIDS (ODHA) adalah individu yang telah terdiagnosis HIV dan mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
3. Pelayanan Rawat Jalan HIV/AIDS adalah pelayanan HIV/AIDS yang diberikan tanpa rawat inap, termasuk konseling, tes HIV, dan terapi ARV.
4. Pelayanan Rawat Inap HIV/AIDS adalah pelayanan HIV/AIDS bagi pasien yang memerlukan perawatan intensif di ruang rawat inap.
5. Pelayanan Gawat Darurat HIV/AIDS adalah pelayanan segera bagi pasien HIV/AIDS dengan kondisi kegawatdaruratan.
6. Pelayanan PITC adalah tes dan konseling HIV yang ditawarkan secara aktif oleh tenaga kesehatan kepada pasien dengan indikasi medis atau faktor risiko.
7. Pelayanan PMTCT adalah pelayanan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, dan menyusui.
8. Terapi Antiretroviral (ARV) adalah pengobatan untuk menekan replikasi virus HIV dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
9. Penatalaksanaan Infeksi Oportunistik adalah pelayanan diagnosis dan pengobatan infeksi yang muncul akibat penurunan sistem imun pada pasien HIV.
10. Rujukan HIV/AIDS adalah proses pemindahan pasien atau spesimen ke fasilitas lain sesuai kebutuhan medis dan kemampuan pelayanan.
11. Konseling HIV adalah proses pemberian informasi, dukungan, dan pengambilan keputusan terkait pemeriksaan dan pengobatan HIV.
12. Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan dokumentasi dan pelaporan kasus serta layanan HIV/AIDS sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Keselamatan Pasien adalah upaya menjamin pelayanan HIV/AIDS yang aman dan meminimalkan risiko kesalahan.

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

2.1 Struktur Organisasi Tim Pelayanan HIV AIDS

Tabel 2.2.1 Struktur

Ketua Tim	:	dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD
Sekretaris	:	Vira Agustin Sintia Putri, AMd.Kep
Anggota		
1. Farmasi	:	Ayu Indra Irmia, AMd.Farm
2. Laboratorium	:	Anita Suprihatiningrum, AMd.Kes
3. Pencatatan dan Pelaporan	:	Roihatul Jannah, S.Kep.,Ns
4. PKRS	:	Novi Hidayati, S.Tr.Kes

2.2 Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Ketua Tim

a. Uraian Tugas

- 1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan HIV/AIDS di rumah sakit.
- 2) Menyusun perencanaan program pelayanan HIV/AIDS.
- 3) Mengorganisasikan pelaksanaan pelayanan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- 4) Mengkoordinasikan tim multidisiplin (dokter, perawat, laboratorium, farmasi, konselor, dll.).
- 5) Memastikan pelaksanaan pelayanan sesuai standar akreditasi dan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Mengawasi pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program HIV/AIDS.
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program secara berkala.
- 8) Mengembangkan jejaring rujukan dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan lain

b. Tanggung Jawab

- 1) Menjamin mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan HIV/AIDS.
- 2) Menjamin ketersediaan dan optimalisasi sumber daya (SDM, sarana, dan logistik).
- 3) Menjamin kerahasiaan status HIV pasien serta pelayanan tanpa diskriminasi.
- 4) Menjamin kepatuhan terhadap standar prosedur operasional (SPO).
- 5) Menjamin kelancaran koordinasi antar unit terkait dalam pelayanan HIV/AIDS.
- 6) Bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja program HIV/AIDS

c. Wewenang

- 1) Memberikan arahan dan keputusan dalam pelaksanaan pelayanan HIV/AIDS.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh anggota tim pelayanan HIV/AIDS.
- 3) Mengusulkan kebutuhan sumber daya (SDM, sarana, logistik) kepada manajemen rumah sakit.
- 4) Mengakses data dan informasi terkait pelayanan HIV/AIDS untuk

keperluan monitoring dan evaluasi.

- 5) Mengembangkan kebijakan teknis dan prosedur pelayanan HIV/AIDS sesuai kebutuhan.
- 6) Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal terkait program HIV/AIDS

2. Sekretaris

a. Uraian Tugas

- 1) Mengelola administrasi dan kesekretariatan tim pelayanan HIV/AIDS.
- 2) Menyusun rencana kegiatan dan jadwal kerja tim bersama ketua tim.
- 3) Menyiapkan bahan rapat, notulen, dan dokumentasi kegiatan tim.
- 4) Mengkoordinasikan pengumpulan data dan laporan dari unit terkait.
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan program HIV/AIDS secara berkala.
- 6) Mengelola sistem pencatatan dan pelaporan program HIV/AIDS.
- 7) Mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi program.
- 8) Memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal tim

b. Tanggung Jawab

- 1) Menjamin tertib administrasi dan dokumentasi kegiatan pelayanan HIV/AIDS.
- 2) Menjamin ketersediaan data dan laporan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.
- 3) Menjaga kerahasiaan data dan informasi pasien HIV/AIDS.
- 4) Menjamin kelancaran koordinasi administratif antar anggota tim dan unit terkait.
- 5) Mendukung pencapaian indikator kinerja program HIV/AIDS.

c. Wewenang

- 1) Mengakses data dan informasi yang diperlukan untuk pencatatan dan pelaporan program HIV/AIDS.
- 2) Meminta data dan laporan dari unit terkait sesuai kebutuhan program.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan administrasi dan pelaporan tim.
- 4) Memberikan rekomendasi administratif kepada ketua tim terkait pelaksanaan program.
- 5) Berkoordinasi dengan unit internal dan eksternal dalam hal administrasi dan pelaporan.

3. Farmasi

a. Uraian Tugas

- 1) Melaksanakan pengelolaan obat antiretroviral (ARV) dan obat pendukung meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi.
- 2) Melayani pemberian obat kepada pasien sesuai resep dan standar pelayanan kefarmasian.
- 3) Memberikan informasi dan edukasi obat kepada pasien (cara penggunaan, kepatuhan, efek samping, interaksi obat).
- 4) Melakukan pemantauan terapi obat (drug monitoring) dan efek samping (farmakovigilans).
- 5) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan penggunaan ARV secara akurat dan berkala.
- 6) Berkoordinasi dengan tim pelayanan dalam mendukung kesinambungan terapi pasien.

-
- 7) Menjamin penerapan prinsip FIFO/FEFO dalam pengelolaan obat
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Menjamin ketersediaan ARV dan obat pendukung secara cukup dan berkesinambungan.
 - 2) Menjamin mutu, keamanan, dan penyimpanan obat sesuai standar.
 - 3) Menjamin ketepatan pemberian obat (tepat pasien, obat, dosis, waktu, dan cara).
 - 4) Menjamin kerahasiaan data pasien terkait terapi HIV/AIDS.
 - 5) Menjamin kepatuhan terhadap standar prosedur operasional (SPO) pelayanan kefarmasian.
 - 6) Mendukung peningkatan kepatuhan terapi pasien HIV/AIDS
 - c. Wewenang
 - 1) Mengelola dan mengendalikan stok ARV dan obat pendukung.
 - 2) Memberikan informasi dan rekomendasi terkait penggunaan obat kepada tenaga kesehatan dan pasien.
 - 3) Menolak atau mengklarifikasi resep yang tidak sesuai standar atau berpotensi membahayakan pasien.
 - 4) Mengakses data terkait terapi obat pasien untuk kepentingan pelayanan dan pelaporan.
 - 5) Mengusulkan kebutuhan obat dan perbaikan sistem pengelolaan farmasi kepada manajemen
4. Laboratorium
- a. Uraian Tugas
 - 1) Melaksanakan pemeriksaan laboratorium terkait HIV/AIDS sesuai standar (skrining, konfirmasi, dan monitoring).
 - 2) Melakukan pengambilan, penanganan, penyimpanan, dan pengiriman spesimen sesuai prosedur.
 - 3) Menjamin pelaksanaan pemeriksaan dengan prinsip mutu dan keselamatan (QC/QA).
 - 4) Mencatat dan melaporkan hasil pemeriksaan secara akurat dan tepat waktu.
 - 5) Berkoordinasi dengan tim pelayanan terkait kebutuhan pemeriksaan pasien HIV/AIDS.
 - 6) Melaksanakan pemeliharaan, kalibrasi, dan uji fungsi peralatan laboratorium.
 - 7) Menerapkan prinsip biosafety dan biosecurity dalam setiap kegiatan laboratorium
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Menjamin keakuratan dan keandalan hasil pemeriksaan laboratorium.
 - 2) Menjamin keselamatan petugas, pasien, dan lingkungan dari risiko infeksi.
 - 3) Menjamin kerahasiaan hasil pemeriksaan dan status HIV pasien.
 - 4) Menjamin ketersediaan dan mutu reagen serta bahan habis pakai.
 - 5) Menjamin kepatuhan terhadap standar prosedur operasional (SPO) laboratorium
 - c. Wewenang
 - 1) Melaksanakan dan memvalidasi hasil pemeriksaan laboratorium sesuai kompetensi.
 - 2) Menolak atau meminta ulang spesimen yang tidak memenuhi syarat.

- 3) Mengakses data pasien yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pelaporan.
- 4) Mengusulkan kebutuhan alat, reagen, dan peningkatan mutu laboratorium.
- 5) Berkoordinasi dengan laboratorium rujukan untuk pemeriksaan lanjutan

5. Perawat

a. Uraian Tugas

- 1) Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien HIV/AIDS sesuai standar praktik keperawatan.
- 2) Melakukan pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan.
- 3) Membantu pelaksanaan pemeriksaan dan tindakan medis.
- 4) Melaksanakan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga terkait HIV/AIDS, kepatuhan terapi ARV, dan pencegahan penularan.
- 5) Melakukan pemantauan kondisi klinis pasien dan efek samping terapi.
- 6) Menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dalam setiap tindakan.
- 7) Melakukan pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan secara lengkap dan akurat.
- 8) Berkoordinasi dengan tim multidisiplin dalam pelayanan pasien HIV/AIDS

b. Tanggung Jawab

- 1) Menjamin mutu dan keselamatan pasien dalam asuhan keperawatan.
- 2) Menjamin pelaksanaan asuhan keperawatan sesuai standar prosedur operasional (SPO).
- 3) Menjaga kerahasiaan status HIV pasien dan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.
- 4) Menjamin kepatuhan terhadap prinsip PPI dan keselamatan kerja.
- 5) Mendukung kepatuhan pasien terhadap terapi dan perawatan.

c. Wewenang

- 1) Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai kompetensi dan kewenangan klinis.
- 2) Mengakses data pasien untuk kepentingan asuhan keperawatan.
- 3) Memberikan edukasi dan konseling dasar kepada pasien dan keluarga.
- 4) Melaporkan perubahan kondisi pasien kepada dokter atau tim terkait.
- 5) Mengusulkan kebutuhan sarana, prasarana, dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan

6. PKRS

a. Uraian Tugas

- 1) Menyusun dan melaksanakan program promosi kesehatan terkait HIV/AIDS di rumah sakit.
- 2) Mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang HIV/AIDS.
- 3) Melaksanakan edukasi kepada pasien, keluarga, dan pengunjung tentang pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan HIV/AIDS.

-
- 4) Mendukung kegiatan konseling HIV bersama tim pelayanan (PITC/PMTCT).
 - 5) Melakukan penyuluhan kelompok maupun individu di area pelayanan.
 - 6) Berkoordinasi dengan tim HIV/AIDS dalam pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif.
 - 7) Melakukan dokumentasi dan pelaporan kegiatan PKRS terkait HIV/AIDS
- b. Tanggung Jawab
- 1) Menjamin terselenggaranya edukasi HIV/AIDS yang benar, jelas, dan tidak menimbulkan stigma.
 - 2) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasien serta masyarakat tentang HIV/AIDS.
 - 3) Menjamin materi edukasi sesuai dengan standar akreditasi dan ketentuan perundang-undangan.
 - 4) Menjaga kerahasiaan status pasien dalam setiap kegiatan edukasi.
 - 5) Mendukung upaya pencegahan penularan dan peningkatan kepatuhan terapi pasien.
- c. Wewenang
- 1) Menyusun dan mengembangkan materi edukasi HIV/AIDS.
 - 2) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan edukasi di lingkungan rumah sakit.
 - 3) Berkoordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan program promosi kesehatan.
 - 4) Mengakses data agregat (non-identitas) untuk keperluan perencanaan program edukasi.
 - 5) Mengusulkan program dan inovasi promosi kesehatan kepada manajemen rumah sakit.

BAB III

STANDAR FASILITAS

3.1 Ruang Pelayanan HIV/AIDS

Ruang pelayanan HIV/AIDS merupakan area utama dalam pemberian layanan yang harus memenuhi aspek privasi, keamanan, kenyamanan, serta pencegahan infeksi. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Ketersediaan Ruang
Rumah sakit menyediakan ruang pelayanan HIV/AIDS yang khusus atau terintegrasi dengan layanan lain, dengan tetap menjamin mutu pelayanan dan tidak menimbulkan stigma.
2. Privasi dan Kerahasiaan
Ruangan harus mampu menjamin kerahasiaan status HIV pasien, antara lain dengan desain tertutup, pembatas yang memadai, dan pengaturan alur pasien yang tidak membuka identitas atau diagnosis.
3. Kenyamanan dan Keamanan
Ruang bersih, rapi, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik, serta dilengkapi sarana tempat duduk yang memadai untuk pasien dan petugas.
4. Pengaturan Alur Pelayanan
Ruang pelayanan mendukung alur pelayanan yang jelas dan efisien (pendaftaran, konseling, pemeriksaan, pengobatan) untuk mengurangi waktu tunggu dan mencegah penumpukan pasien.
5. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Dilengkapi fasilitas cuci tangan/hand hygiene, ketersediaan alat pelindung diri (APD), serta pengelolaan limbah medis sesuai standar.
6. Aksesibilitas
Ruang pelayanan mudah dijangkau oleh pasien, termasuk kelompok rentan, tanpa diskriminasi.
7. Keamanan Lingkungan
Menjamin keamanan pasien, petugas, dan aset, termasuk pengaturan akses masuk dan keluar ruangan.
8. Integrasi Layanan
Ruang pelayanan dapat terhubung atau terkoordinasi dengan unit lain seperti laboratorium, farmasi, dan ruang konseling untuk mendukung pelayanan yang komprehensif.
9. Standar Luas dan Kelayakan
Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah pasien dan jenis pelayanan, serta memenuhi standar kelayakan bangunan rumah sakit.
10. Pemeliharaan Ruangan
Dilakukan pembersihan, desinfeksi, dan pemeliharaan secara rutin untuk menjamin keselamatan pasien dan mutu pelayanan.

3.2 Ruang Konseling

Ruang konseling merupakan fasilitas penting dalam pelayanan HIV/AIDS untuk mendukung proses komunikasi, edukasi, dan pengambilan keputusan pasien secara aman dan nyaman. Standarnya meliputi:

1. Ketersediaan Ruang Khusus
Rumah sakit menyediakan ruang konseling khusus untuk layanan konseling pra dan pasca tes HIV yang terpisah dari area umum.

2. Privasi dan Kerahasiaan
Ruangan tertutup, tidak tembus pandang, dan kedap suara sehingga menjamin kerahasiaan informasi serta status HIV pasien.
3. Kenyamanan Ruang
Dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik, suhu ruangan nyaman, serta suasana yang tenang untuk mendukung komunikasi efektif antara konselor dan pasien.
4. Sarana Pendukung Konseling
Tersedia meja, kursi yang nyaman (posisi sejajar/tidak berjarak kaku), alat bantu edukasi (leaflet, media KIE), serta alat tulis untuk mendukung proses konseling.
5. Keamanan dan Akses Terbatas
Akses ke ruang konseling dibatasi hanya untuk pasien dan petugas terkait guna menjaga kerahasiaan dan keamanan.
6. Pengaturan Alur yang Tidak Stigmatisasi
Lokasi dan akses ruang konseling diatur agar tidak menimbulkan stigma, misalnya tidak diberi label khusus yang mengidentifikasi layanan HIV.
7. Penerapan PPI
Tersedia fasilitas hand hygiene dan kebersihan ruangan terjaga sesuai standar pencegahan dan pengendalian infeksi.
8. Dokumentasi dan Penyimpanan Data
Tersedia tempat penyimpanan dokumen yang aman (terkunci) atau sistem elektronik yang menjamin kerahasiaan hasil konseling dan tes HIV.
9. Pemeliharaan Ruang
Dilakukan pembersihan dan pemeliharaan rutin untuk menjamin kelayakan, kenyamanan, dan keselamatan.

3.3 Ruang Pemeriksaan dan Tindakan

Ruang pemeriksaan dan tindakan merupakan fasilitas untuk pelayanan klinis pasien HIV/AIDS yang harus memenuhi aspek keselamatan, mutu, dan pencegahan infeksi. Standarnya meliputi:

1. Ketersediaan Ruang
Rumah sakit menyediakan ruang pemeriksaan dan tindakan yang memadai, dapat berupa ruang khusus atau terintegrasi dengan layanan lain tanpa menimbulkan stigma.
2. Privasi dan Kerahasiaan
Ruangan menjamin privasi pasien dengan pembatas yang memadai (tirai/partisi/ruang tertutup) serta menjaga kerahasiaan status HIV.
3. Kebersihan dan Kelayakan Ruang
Ruangan bersih, tertata rapi, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik, serta memenuhi standar sanitasi dan keselamatan.
4. Peralatan Medis
Dilengkapi alat pemeriksaan dan tindakan sesuai kebutuhan (bed periksa, alat tanda vital, alat tindakan medis) yang berfungsi baik, aman, dan terkalibrasi.
5. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Tersedia fasilitas cuci tangan/hand hygiene, alat pelindung diri (APD), serta tempat pembuangan limbah medis dan benda tajam (safety box) sesuai standar.
6. Keamanan Tindakan
Pelaksanaan tindakan medis harus mengikuti standar prosedur operasional (SPO) untuk menjamin keselamatan pasien dan petugas.

7. Aksesibilitas dan Alur Pelayanan
Ruangan mudah diakses dan mendukung alur pelayanan yang efektif untuk menghindari penumpukan pasien serta mempercepat pelayanan.
8. Sarana Pendukung
Tersedia trolley tindakan, obat emergensi, serta perlengkapan penunjang lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.
9. Pengelolaan Limbah Medis
Limbah hasil tindakan dikelola sesuai standar untuk mencegah penularan infeksi dan menjaga keselamatan lingkungan.
10. Pemeliharaan dan Evaluasi
Ruangan dan peralatan dilakukan pembersihan, desinfeksi, pemeliharaan, dan evaluasi secara berkala untuk menjamin mutu dan keselamatan pelayanan.

3.4 Fasilitas Laboratorium

Fasilitas laboratorium dalam pelayanan HIV/AIDS berperan penting untuk diagnosis, pemantauan terapi, dan pengendalian penyakit. Standarnya meliputi:

1. Ketersediaan Jenis Pemeriksaan
Rumah sakit harus mampu menyediakan pemeriksaan HIV sesuai tingkat layanan, meliputi skrining (rapid test/ELISA), konfirmasi, dan pemantauan. Bila belum mampu, wajib bekerja sama dengan laboratorium rujukan yang terakreditasi.
2. Sumber Daya dan Kompetensi
Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga laboratorium yang kompeten dan terlatih dalam pemeriksaan HIV serta penanganan spesimen infeksius.
3. Jaminan Mutu (Quality Assurance)
Laboratorium wajib menerapkan pengendalian mutu internal (QC) dan mengikuti uji mutu eksternal (EQA/proficiency test) untuk menjamin keakuratan hasil pemeriksaan.
4. Peralatan dan Reagen
Tersedia peralatan yang sesuai standar dan berfungsi baik, serta reagen dan bahan habis pakai yang berkualitas, tidak kedaluwarsa, dan disimpan sesuai ketentuan.
5. Pengelolaan Spesimen
Terdapat prosedur baku untuk pengambilan, pelabelan, penyimpanan, dan pengiriman spesimen yang aman dan dapat ditelusuri (traceable).
6. Biosafety dan Biosecurity
Laboratorium menerapkan keselamatan kerja, termasuk penggunaan APD, fasilitas hand hygiene, lemari biosafety (bila diperlukan), serta pengelolaan limbah infeksius sesuai standar.
7. Sistem Pencatatan dan Pelaporan
Hasil pemeriksaan dicatat dan dilaporkan secara akurat, tepat waktu, serta menjamin kerahasiaan status HIV pasien.
8. Waktu Pelayanan (Turn Around Time)
Laboratorium menetapkan dan memenuhi standar waktu pelayanan hasil pemeriksaan untuk mendukung keputusan klinis yang cepat.
9. Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat
Seluruh peralatan laboratorium wajib dilakukan kalibrasi, uji fungsi, dan pemeliharaan secara berkala.
10. Jejaring Rujukan
Rumah sakit memiliki sistem rujukan laboratorium yang jelas untuk pemeriksaan yang tidak tersedia, termasuk mekanisme pengiriman spesimen yang aman.

3.5 Fasilitas Farmasi

Fasilitas farmasi dalam pelayanan HIV/AIDS berperan penting untuk menjamin ketersediaan, mutu, dan keamanan terapi, khususnya obat antiretroviral (ARV). Standarnya meliputi:

1. Ketersediaan Obat
Rumah sakit menjamin ketersediaan ARV dan obat pendukung (infeksi oportunistik, profilaksis) secara cukup dan berkesinambungan.
2. Pengelolaan Logistik Obat
Meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, serta pengendalian stok sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penyimpanan Obat
Obat disimpan sesuai standar (suhu, kelembaban, keamanan), dengan penerapan prinsip FIFO/FEFO, serta dilengkapi pemantauan suhu dan pencatatan yang baik.
4. Distribusi dan Pelayanan Obat
Pendistribusian dilakukan dengan prinsip tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara pemberian, serta disertai etiket dan informasi yang jelas.
5. Pelayanan Informasi Obat
Petugas farmasi memberikan edukasi kepada pasien terkait penggunaan ARV, kepatuhan terapi, efek samping, dan interaksi obat.
6. Farmakovigilans
Dilakukan pemantauan, pencatatan, dan pelaporan efek samping obat (ESO) untuk menjamin keamanan terapi pasien.
7. Sistem Pencatatan dan Pelaporan
8. Tersedia sistem pencatatan stok dan penggunaan ARV yang akurat, terintegrasi, dan dapat ditelusuri.
9. Keamanan dan Akses
Penyimpanan obat harus aman dan hanya dapat diakses oleh petugas berwenang untuk mencegah kehilangan dan penyalahgunaan.
10. Pengelolaan Obat Kedaluwarsa/Rusak
Obat yang tidak layak pakai harus dipisahkan dan dimusnahkan sesuai ketentuan.
11. Kompetensi SDM Farmasi
Pelayanan dilakukan oleh apoteker/tenaga teknis kefarmasian yang kompeten dan terlatih dalam pelayanan HIV/AIDS.

3.6 Sarana Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Sarana PPI bertujuan mencegah penularan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan serta melindungi pasien dan petugas. Standarnya meliputi:

1. Fasilitas Hand Hygiene
Tersedia wastafel dengan air mengalir, sabun, tisu sekali pakai, dan/atau hand rub berbasis alkohol di setiap titik pelayanan (5 momen cuci tangan).
2. Alat Pelindung Diri (APD)
Tersedia APD sesuai risiko pelayanan, seperti sarung tangan, masker, pelindung wajah, gaun pelindung, dan apron, serta digunakan sesuai prosedur.
3. Pengelolaan Limbah Medis
Tersedia tempat limbah infeksius dan non-infeksius yang terpisah, kantong berwarna sesuai kode, serta safety box untuk benda tajam, dengan sistem pengelolaan sesuai standar.

4. Sterilisasi dan Desinfeksi
Tersedia sarana untuk pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi alat medis sesuai tingkat risiko (critical, semi-critical, non-critical).
5. Pengelolaan Linen dan Lingkungan
Tersedia sistem pengelolaan linen terkontaminasi serta kebersihan lingkungan pelayanan yang rutin dan terstandar.
6. Pengendalian Pajanan
Tersedia fasilitas dan prosedur untuk penanganan pajanan (tertusuk jarum, kontak darah/cairan tubuh), termasuk akses cepat ke profilaksis pasca pajanan (PEP).
7. Ventilasi dan Sirkulasi Udara
Ruang memiliki ventilasi yang baik untuk mengurangi risiko penularan infeksi.
8. Edukasi dan Kepatuhan PPI
Tersedia media edukasi serta monitoring kepatuhan petugas terhadap penerapan PPI.
9. Ketersediaan SOP PPI
Tersedia standar prosedur operasional terkait PPI yang mudah diakses dan diterapkan oleh seluruh petugas.
10. Pemantauan dan Evaluasi
Dilakukan monitoring dan audit PPI secara berkala untuk menjamin efektivitas pencegahan infeksi.

3.7 Peralatan Medis

Peralatan medis dalam pelayanan HIV/AIDS harus menjamin keselamatan pasien, ketepatan diagnosis, dan efektivitas terapi. Standarnya meliputi:

1. Ketersediaan Peralatan
Rumah sakit menyediakan peralatan medis sesuai jenis pelayanan HIV/AIDS, seperti alat pemeriksaan tanda vital, bed periksa, alat tindakan, serta peralatan penunjang lainnya.
2. Kesesuaian Standar Alat
Peralatan memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelayakan sesuai regulasi alat kesehatan yang berlaku.
3. Kondisi dan Fungsi Alat
Seluruh alat dalam kondisi baik, siap pakai, dan dilakukan uji fungsi secara rutin sebelum digunakan.
4. Kalibrasi dan Pemeliharaan
Peralatan medis dilakukan kalibrasi, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sesuai jadwal untuk menjamin akurasi dan keselamatan.
5. Penggunaan Sesuai SPO
6. Penggunaan alat mengikuti standar prosedur operasional (SPO) untuk mencegah kesalahan dan risiko terhadap pasien maupun petugas.
7. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Peralatan dibersihkan, didesinfeksi, atau disterilkan sesuai klasifikasi risiko untuk mencegah penularan infeksi.
8. Ketersediaan Peralatan Emergensi
Tersedia peralatan kegawatdaruratan (emergency set) untuk penanganan kondisi darurat pada pasien HIV/AIDS.
9. Keamanan Penggunaan Alat
Terdapat sistem pengamanan untuk mencegah kerusakan, kehilangan, dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang.
10. Pencatatan dan Inventarisasi

Dilakukan pencatatan, inventarisasi, serta pelacakan penggunaan alat secara tertib dan terintegrasi.

11. Pelatihan Penggunaan Alat

Petugas yang menggunakan peralatan medis memiliki kompetensi dan pelatihan yang sesuai.

3.8 Sistem Informasi dan Rekam Medis

Sistem informasi dan rekam medis dalam pelayanan HIV/AIDS berperan penting untuk menjamin kesinambungan pelayanan, akurasi data, serta kerahasiaan status pasien. Standarnya meliputi:

1. Ketersediaan Sistem Informasi
Rumah sakit memiliki sistem informasi (manual atau elektronik) yang mendukung pencatatan, pelaporan, dan pemantauan pelayanan HIV/AIDS secara terintegrasi.
2. Rekam Medis Lengkap dan Akurat
Setiap pasien HIV/AIDS memiliki rekam medis yang lengkap, meliputi identitas, hasil pemeriksaan, diagnosis, terapi (termasuk ARV), serta tindak lanjut pelayanan.
3. Kerahasiaan Data Pasien
Sistem menjamin kerahasiaan status HIV pasien melalui pembatasan akses, penggunaan kode/identitas khusus, serta perlindungan data sesuai ketentuan hukum.
4. Akses Terbatas dan Berwenang
Rekam medis hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan terkait langsung dengan pelayanan pasien.
5. Keamanan Sistem
Untuk sistem elektronik, tersedia pengamanan seperti password, enkripsi, dan backup data guna mencegah kehilangan atau kebocoran informasi.
6. Keterpaduan Data
Sistem informasi terintegrasi antar unit (rawat jalan, rawat inap, laboratorium, farmasi) untuk mendukung kesinambungan pelayanan.
7. Pencatatan dan Pelaporan Program
Rumah sakit melakukan pencatatan dan pelaporan kasus HIV/AIDS secara berkala kepada instansi terkait sesuai format dan ketentuan yang berlaku.
8. Ketepatan Waktu dan Keakuratan Data
Data dicatat secara real time atau tepat waktu serta diverifikasi untuk menjamin keakuratan informasi.
9. Penyimpanan dan Retensi Dokumen
Rekam medis disimpan dengan aman sesuai masa retensi yang ditetapkan serta mudah ditelusuri kembali bila diperlukan.
10. Monitoring dan Evaluasi
Dilakukan audit dan evaluasi berkala terhadap sistem informasi dan rekam medis untuk meningkatkan mutu dan kepatuhan.

3.9 Sarana Edukasi

Sarana edukasi dalam pelayanan HIV/AIDS bertujuan meningkatkan pengetahuan, kepatuhan terapi, serta pencegahan penularan. Standarnya meliputi:

1. Ketersediaan Media Edukasi
Rumah sakit menyediakan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) seperti leaflet, poster, booklet, video, atau media digital terkait HIV/AIDS.

-
2. Isi Materi Edukasi
Materi mencakup informasi tentang HIV/AIDS, cara penularan dan pencegahan, pentingnya tes HIV, terapi antiretroviral (ARV), kepatuhan minum obat, serta tanda bahaya.
 3. Bahasa dan Penyajian
Materi disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, jelas, tidak menimbulkan stigma, dan sesuai dengan tingkat pendidikan serta budaya pasien.
 4. Aksesibilitas Edukasi
Sarana edukasi mudah diakses oleh pasien dan keluarga di area pelayanan seperti ruang tunggu, ruang konseling, dan ruang perawatan.
 5. Kerahasiaan dan Non-Diskriminasi
Penyampaian edukasi menjaga kerahasiaan status pasien serta dilakukan tanpa stigma dan diskriminasi.
 6. Keterlibatan Tenaga Kesehatan
Edukasi diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten melalui konseling langsung maupun media pendukung.
 7. Pendokumentasian Edukasi
Setiap kegiatan edukasi dicatat dalam rekam medis sebagai bagian dari pelayanan pasien.
 8. Evaluasi dan Pembaruan Materi
Materi edukasi dievaluasi dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan terbaru.

BAB IV

TATA LAKSANA PELAYANAN

4.1 Program Penanggulangan HIV

1. Perencanaan Program

Perencanaan merupakan tahap awal untuk memastikan program berjalan efektif, terarah, dan sesuai kebutuhan.

a. Analisis situasi

- 1) Mengidentifikasi jumlah kasus HIV/AIDS (ODHA)
- 2) Mengkaji faktor risiko di wilayah layanan
- 3) Menilai ketersediaan SDM, sarana, dan prasarana
- 4) Mengidentifikasi masalah (misalnya rendahnya cakupan tes HIV)

b. Penetapan tujuan dan sasaran

- 1) Menentukan tujuan umum (misalnya menurunkan angka penularan HIV)
- 2) Menetapkan tujuan khusus (peningkatan cakupan tes, kepatuhan ARV)
- 3) Menentukan sasaran (kelompok berisiko, ibu hamil, pasien TB, dll.)

c. Penyusunan rencana kegiatan

Meliputi:

- 1) Kegiatan promotif (edukasi, KIE)
- 2) Preventif (skrining, PPIA)
- 3) Kuratif (pengobatan ARV)
- 4) Rehabilitatif (dukungan psikososial)

d. Perencanaan sumber daya

- 1) SDM (dokter, perawat, konselor, analis lab)
- 2) Logistik (ARV, reagen, alat kesehatan)
- 3) Anggaran (dana operasional program)

e. Penyusunan kebijakan dan SPO

- 1) Pedoman pelayanan HIV/AIDS
- 2) SOP VCT, PDP, rujukan, pencatatan
- 3) Penetapan alur pelayanan

f. Penetapan indikator kinerja

- 1) Cakupan tes HIV
- 2) Persentase ODHA yang mendapatkan ARV
- 3) Tingkat kepatuhan pengobatan

2. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan dilakukan sesuai rencana dengan pendekatan komprehensif dan terintegrasi.

a. Promosi dan pencegahan

- 1) Edukasi HIV/AIDS kepada pasien dan masyarakat
- 2) Konseling perubahan perilaku
- 3) Pencegahan penularan ibu ke anak (PPIA)
- 4) Penyuluhan di fasilitas kesehatan dan komunitas

b. Layanan tes dan konseling HIV

- 1) Pelaksanaan VCT dan PITC
- 2) Konseling pra dan pasca tes
- 3) Pemeriksaan HIV sesuai algoritma nasional

c. Perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP)

- 1) Penilaian klinis pasien

- 2) Pemberian terapi ARV
- 3) Penanganan infeksi oportunistik
- 4) Monitoring kepatuhan pasien
- d. Pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI)
 - 1) Kewaspadaan standar
 - 2) Penggunaan APD
 - 3) Pengelolaan limbah medis
 - 4) Penanganan paparan (PEP)
- e. Pelayanan terintegrasi
 - 1) Integrasi dengan TB, IMS, KIA, dan NAPZA
 - 2) Kolaborasi lintas program
- f. Sistem rujukan
 - 1) Rujukan internal dan eksternal
 - 2) Koordinasi dengan fasilitas kesehatan lain dan komunitas
- g. Pencatatan dan pelaporan
 - 1) Input data ke sistem (SIHA)
 - 2) Pelaporan rutin ke Dinas Kesehatan
 - 3) Menjaga kerahasiaan pasien

4.2 Rujukan HIV/AIDS

1. Penilaian dan Indikasi Rujukan

Tenaga medis wajib:

- a. Melakukan asesmen klinis menyeluruh
- b. Menentukan indikasi rujukan, seperti:
 - 1) Memerlukan pemeriksaan lanjutan (CD4, viral load)
 - 2) Memerlukan dokter spesialis/subspesialis
 - 3) Terjadi komplikasi atau infeksi oportunistik berat
 - 4) Keterbatasan fasilitas di unit asal
- c. Rujukan hanya dilakukan bila pelayanan tidak dapat ditangani optimal di fasilitas asal

2. Edukasi dan komunikasi kepada pasien

- a. Jelaskan diagnosis, kondisi, dan alasan rujukan
- b. Informasikan tempat tujuan rujukan
- c. Jelaskan proses lanjutan pengobatan

3. Persetujuan Tindakan

- a. Meminta persetujuan pasien/keluarga
- b. Mendokumentasikan persetujuan dalam rekam medis

4. Koordinasi dengan fasilitas tujuan

- a. Menghubungi fasilitas rujukan
- b. Memastikan kesiapan menerima pasien
- c. Menentukan jadwal dan mekanisme penerimaan

5. Persiapan administrasi dan dokumen

Petugas wajib menyiapkan:

- a. Surat rujukan resmi
- b. Resume medis lengkap
- c. Hasil pemeriksaan penunjang
- d. Riwayat terapi termasuk ARV

6. Stabilisasi dan persiapan klinis pasien

- a. Menstabilkan kondisi pasien sebelum dirujuk
- b. Memberikan terapi awal sesuai kebutuhan
- c. Membekali pasien dengan obat sementara (termasuk ARV)

7. Transportasi dan pendampingan

- a. Menentukan jenis transportasi sesuai kondisi pasien
- b. Menyertakan tenaga kesehatan jika kondisi pasien tidak stabil

- c. Menjamin keselamatan selama perjalanan
- 8. Serah terima pasien
 - a. Melakukan komunikasi efektif menggunakan metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)
 - b. Menyerahkan pasien beserta dokumen kepada fasilitas penerima
 - c. Memastikan pasien benar-benar diterima
- 9. Dokumentasi
 - a. Mencatat seluruh proses rujukan dalam rekam medis
 - b. Mendokumentasikan waktu, alasan, dan tujuan rujukan
- 10. Tindak lanjut dan rujukan balik
 - a. Memantau status pasien setelah dirujuk
 - b. Menerima rujukan balik dari fasilitas tujuan
 - c. Melanjutkan perawatan sesuai rekomendasi

4.3 Pelayanan PITC dan PMTC

- 1. Tata laksana pelayanan PITC
 - a. Sasaran
 - 1) Pasien TB
 - 2) Ibu hamil
 - 3) Pasien IMS
 - 4) Pasien dengan gejala klinis mengarah ke HIV
 - 5) Pasien rawat inap/IGD dengan indikasi medis
 - b. Ketentuan
 - 1) Wajib menjaga kerahasiaan
 - 2) Tidak diskriminatif
 - 3) Dilakukan oleh tenaga terlatih
 - 4) Terintegrasi dengan layanan lain (TB, KIA, IMS)
 - c. Tata Laksana
 - 1) Skrinning dan identifikasi
 - a) Petugas mengidentifikasi pasien dengan indikasi tes HIV
 - b) Menentukan kelayakan dilakukan PITC
 - c) Dilakukan secara aktif oleh tenaga kesehatan (tidak menunggu permintaan pasien).
 - 2) Edukasi dan konseling pra tes
 - a) Jelaskan tujuan dan manfaat tes HIV
 - b) Jelaskan prosedur pemeriksaan
 - c) Tekankan kerahasiaan hasil
 - 3) Persetujuan tindakan
 - a) Meminta persetujuan pasien
 - b) Mendokumentasikan persetujuan
 - 4) Pemeriksaan HIV
 - a) Melakukan tes HIV sesuai algoritma nasional
 - b) Menggunakan rapid test atau metode lain yang ditetapkan
 - 5) Konseling pasca tes
 - a) Hasil non-reaktif: edukasi pencegahan
 - b) Hasil reaktif: dukungan psikologis dan rujukan ke layanan PDP
 - 6) Rujukan dan tindak lanjut
 - a) Rujuk pasien dengan hasil positif ke layanan PDP (Perawatan, Dukungan, Pengobatan)
 - b) Jadwalkan kunjungan lanjutan
 - 7) Pencatatan dan pelaporan
 - a) Catat hasil dalam rekam medis dan sistem (SIHA)

- b) Jaga kerahasiaan pasien

2. Tata laksana pelayanan PMTC

a. Sasaran

- 1) Ibu hamil
- 2) Ibu bersalin
- 3) Ibu menyusui
- 4) Bayi dari ibu dengan HIV

b. Ketentuan

- 1) Wajib dilakukan pada semua ibu hamil (opt-out testing)
- 2) Menjamin kerahasiaan
- 3) Tidak diskriminatif
- 4) Terintegrasi dengan layanan KIA
- 5) Menjamin kesinambungan ARV

c. Tata laksana

- 1) Tahap 1 : Pencegahan pada wanita usia produktif
 - a) Edukasi kesehatan reproduksi
 - b) Pencegahan perilaku berisiko
 - c) Skrining HIV
- 2) Tahap 2 : pencegahan pada ibu hamil
 - a) Skrining HIV (PITC pada ANC)
 - Semua ibu hamil ditawarkan tes HIV
 - Dilakukan pada kunjungan antenatal
 - b) Konseling dan informed consent
 - Edukasi manfaat tes
 - Persetujuan tindakan
- 3) Tahap 3 : penatalaksanaan ibu hamil HIV positif
 - a) Pemberian ARV segera (test and treat)
 - b) Pemantauan kehamilan secara rutin
 - c) Pencegahan infeksi oportunistik
- 4) Tahap 4 : Persalinan aman
 - a) Persalinan di fasilitas kesehatan
 - b) Metode persalinan sesuai indikasi medis
 - c) Penerapan PPI
- 5) Tahap 5 : Tatalaksana bayi
 - a) Pemberian profilaksis ARV pada bayi
 - b) Pemberian ASI eksklusif dengan syarat tertentu atau alternatif sesuai pedoman
 - c) Pemeriksaan HIV pada bayi (early infant diagnosis)
- 6) Tahap 6 : tindak lanjut ibu dan bayi
 - a) Monitoring kepatuhan ARV ibu
 - b) Pemantauan tumbuh kembang bayi
 - c) Tes HIV lanjutan pada bayi
- 7) Pencatatan dan pelaporan
 - a) Dicatat dalam register KIA dan HIV
 - b) Dilaporkan ke sistem nasional (SIHA)

4.4 Pelayanan ODHA

1. Penerimaan dan Registrasi Pasien

- a. Mendaftarkan pasien sesuai prosedur
- b. Memberikan nomor identitas unik (kode pasien)
- c. Menjamin kerahasiaan status HIV
- d. Menghindari stigma dan menjaga privasi pasien

2. Assesmen Awal

Meliputi:

- a. Anamnesis lengkap (riwayat penyakit, faktor risiko)
 - b. Pemeriksaan fisik
 - c. Penilaian stadium klinis (WHO staging)
 - d. Penilaian psikososial
3. Pemeriksaan Penunjang
 - a. Tes CD4
 - b. Viral load (jika tersedia)
 - c. Pemeriksaan laboratorium lain (hematologi, fungsi hati, dll.)
 - d. Skrining TB dan infeksi oportunistik
 4. Konseling HIV/AIDS
 - a. Edukasi tentang penyakit HIV/AIDS
 - b. Konseling kepatuhan minum ARV
 - c. Konseling pencegahan penularan
 - d. Dukungan psikososial
 5. Pemberian Terapi ARV
 - a. Inisiasi ARV segera (test and treat)
 - b. Pemilihan regimen sesuai pedoman nasional
 - c. Edukasi cara minum obat dan efek samping
 - d. ARV harus diberikan seumur hidup dan tidak boleh terputus
 6. Penatalaksanaan Infeksi Oportunistik
 - a. Diagnosis dan terapi infeksi oportunistik (TB, kandidiasis, dll.)
 - b. Profilaksis infeksi tertentu sesuai indikasi
 7. Monitoring dan Evaluasi Klinis
 - a. Monitoring kepatuhan pengobatan
 - b. Evaluasi efek samping ARV
 - c. Pemeriksaan berkala CD4/viral load
 - d. Penilaian keberhasilan terapi
 8. Dukungan Psikososial
 - a. Konseling berkelanjutan
 - b. Dukungan keluarga
 - c. Rujukan ke kelompok dukungan sebaya (peer support)
 9. Pencegahan Penularan
 - a. Edukasi penggunaan kondom
 - b. Pencegahan penularan ibu ke anak (PMTCT)
 - c. Pencegahan penularan di fasilitas kesehatan (PPI)
 10. Pelayanan Terintegrasi
 - a. Integrasi dengan layanan TB, IMS, KIA, dan NAPZA
 - b. Kolaborasi lintas program
 11. Rujukan
 - a. Rujukan internal (antar unit)
 - b. Rujukan eksternal bila diperlukan
 - c. Rujukan balik untuk kesinambungan layanan
 12. Pencatatan dan Pelaporan
 - a. Pencatatan dalam rekam medis
 - b. Input data ke sistem nasional (SIHA)
 - c. Pelaporan ke Dinas Kesehatan

4.5 Penyediaan ARV

1. Ketentuan Penyediaan ARV
 - a. Kontinuitas obat
 - 1) ARV harus tersedia terus-menerus
 - 2) Tidak boleh terjadi putus obat
 - b. Ketepatan dan rasionalitas

-
- 1) Penggunaan sesuai pedoman terapi nasional
 - 2) Resep oleh dokter yang berkompeten
 - c. Keselamatan pasien
 - 1) Pemberian obat sesuai prinsip patient safety
 - 2) Pencegahan medication error
 - d. Kerahasiaan
 - 1) Identitas pasien dijaga
 - 2) Distribusi obat dilakukan dengan menjaga privasi
 - e. Kompetensi SDM
 - 1) Petugas farmasi harus terlatih
 - 2) Memahami manajemen logistik ARV
 - f. Integrasi program
 - 1) Terintegrasi dengan layanan HIV (PDP)
 - 2) Koordinasi dengan program nasional HIV
 2. Perencanaan Kebutuhan ARV
 - a. Menghitung kebutuhan berdasarkan:
 - 1) Jumlah pasien ODHA aktif
 - 2) Regimen terapi yang digunakan
 - 3) Buffer stock (stok pengaman)
 - b. Menggunakan data pemakaian sebelumnya (konsumsi)
 - c. Menyusun rencana kebutuhan obat (RKO)
 3. Pengadaan ARV
 - a. Mengacu pada sistem pengadaan nasional (e-katalog/logistik program HIV)
 - b. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau gudang farmasi pemerintah
 - c. Memastikan obat sesuai standar mutu dan izin edar
 4. Penerimaan dan Verifikasi
 - a. Memeriksa kesesuaian jumlah, jenis, dan kondisi obat
 - b. Memastikan tanggal kedaluwarsa masih aman
 - c. Mendokumentasikan dalam buku penerimaan/logistik
 5. Penyimpanan ARV
 - a. Disimpan sesuai standar:
 - 1) Suhu ruangan sesuai ketentuan
 - 2) Terhindar dari cahaya langsung dan kelembaban
 - b. Menggunakan sistem:
 - 1) FEFO (First Expired First Out)
 - 2) FIFO (First In First Out)
 - c. Pengamanan obat (akses terbatas)
 6. Distribusi dan Penyaluran
 - a. Distribusi ke unit pelayanan (klinik HIV, rawat inap, dll.)
 - b. Penyerahan obat kepada pasien oleh farmasi
 - c. Pemberian sesuai resep dokter dan regimen terapi
 7. Pelayanan Farmasi Klinis
 - a. Edukasi pasien terkait:
 - 1) Cara minum ARV
 - 2) Efek samping
 - 3) Kepatuhan terapi
 - b. Konseling farmasi untuk meningkatkan adherence
 8. Monitoring dan Pengendalian
 - a. Monitoring stok secara berkala
 - b. Pemantauan penggunaan obat
 - c. Deteksi dini kekosongan stok (stock out)
 - d. Pelaporan penggunaan ARV

4.6 Pemantauan dan Evaluasi Program Penanggulangan HIV/AIDS

1. Pemantauan (Monitoring)

a. Penetapan indikator kinerja

Menentukan indikator sesuai program nasional, seperti:

- 1) Jumlah pasien yang dilakukan tes HIV
- 2) Persentase ODHA yang mendapatkan terapi ARV
- 3) Tingkat kepatuhan pasien
- 4) Persentase viral load tersupresi
- 5) Cakupan PITC dan PMTCT

b. Pengumpulan data

1) Data berasal dari:

- a) Rekam medis
- b) Register HIV (SIHA)
- c) Laporan unit (VCT, PDP, laboratorium, farmasi)

2) Dilakukan secara rutin (harian, bulanan)

c. Validasi dan verifikasi data

- 1) Memastikan data akurat, lengkap, dan konsisten
- 2) Cross-check antar unit pelayanan

d. Analisis data

- 1) Membandingkan capaian dengan target
- 2) Mengidentifikasi tren (peningkatan/penurunan kasus)
- 3) Menemukan masalah (misalnya rendahnya kepatuhan ARV)

e. Pelaporan

- 1) Laporan internal rumah sakit (manajemen)
- 2) Laporan eksternal ke Dinas Kesehatan
- 3) Pelaporan melalui sistem nasional (SIHA)

f. Supervisi dan monitoring lapangan

- 1) Supervisi oleh tim HIV/AIDS rumah sakit
- 2) Monitoring implementasi SOP di unit pelayanan
- 3) Evaluasi kepatuhan petugas

2. Evaluasi Program

a. Evaluasi berkala

- 1) Dilakukan secara periodik (bulanan, triwulan, tahunan)
- 2) Menilai efektivitas program secara menyeluruh

b. Audit program dan audit klinis

- 1) Audit kepatuhan terhadap SOP
- 2) Audit penggunaan ARV
- 3) Audit penatalaksanaan pasien

c. Penilaian capaian indikator

- 1) Membandingkan hasil dengan target nasional/RS
- 2) Mengidentifikasi gap (kesenjangan kinerja)

d. Identifikasi masalah dan akar penyebab

Analisis masalah menggunakan metode:

- 1) Root Cause Analysis (RCA)
- 2) Fishbone diagram

e. Penyusunan rencana tindak lanjut

- 1) Menentukan solusi perbaikan
- 2) Menyusun rencana aksi
- 3) Menetapkan penanggung jawab dan waktu pelaksanaan

f. Implementasi perbaikan mutu

- 1) Pelatihan ulang SDM
- 2) Perbaikan SPO

-
- 3) Penguatan sistem pelayanan
 - g. Re-Evaluasi
 - 1) Menilai efektivitas perbaikan
 - 2) Memastikan masalah tidak berulang

BAB V LOGISTIK

5.1 Perencanaan Kebutuhan Logistik

1. Identifikasi jenis logistik yang dibutuhkan
Tentukan daftar obat logistik meliputi:
 - a. Obat ARV
 - b. Obat infeksi oportunistik
 - c. Reagen pemeriksaan HIV (rapid test, CD4, viral load)
 - d. Alat kesehatan dan bahan habis pakai
2. Kumpulkan data dasar perencanaan
 - a. Ambil data jumlah pasien HIV/AIDS aktif (on treatment).
 - b. Ambil data kunjungan pasien baru dan lama.
 - c. Ambil data pemakaian logistik periode sebelumnya.
 - d. Ambil data sisa stok terakhir (stok akhir).
3. Lakukan analisis kebutuhan
 - a. Hitung kebutuhan menggunakan metode:
 - 1) Metode konsumsi (berdasarkan pemakaian sebelumnya).
 - 2) Metode morbiditas/epidemiologi (berdasarkan jumlah kasus).
 - b. Perhitungkan regimen terapi ARV yang digunakan.
4. Perhitungan buffer stock
 - a. Tambahkan stok pengaman (buffer) sesuai kebijakan (misalnya 1–3 bulan).
 - b. Antisipasi keterlambatan distribusi dari pusat/dinas kesehatan.
5. Perhitungkan lead time
 - a. Tentukan waktu tunggu pengadaan/distribusi logistik.
 - b. Sesuaikan waktu pemesanan agar tidak terjadi kekosongan.
6. Susun rencana kebutuhan logistik
 - a. Buat daftar kebutuhan per jenis barang, jumlah, dan periode waktu.
 - b. Susun dalam format perencanaan (RKO/RKA/logistik program HIV).
7. Koordinasikan dengan unit terkait
 - a. Lakukan koordinasi dengan:
 - 1) Instalasi Farmasi
 - 2) Laboratorium
 - 3) Tim HIV/AIDS rumah sakit
 - 4) Bagian perencanaan
8. Ajukan rencana kebutuhan
 - a. Sampaikan rencana kebutuhan kepada manajemen rumah sakit dan/atau Dinas Kesehatan.
 - b. Gunakan sistem yang berlaku (misalnya SIHA atau sistem logistik nasional).
9. Lakukan verifikasi dan validasi
 - a. Verifikasi kesesuaian data kebutuhan dengan data riil.
 - b. Validasi oleh penanggung jawab program HIV/AIDS dan kepala instalasi terkait.
10. Dokumentasikan hasil perencanaan
 - a. Simpan dokumen perencanaan kebutuhan logistik secara tertib.
 - b. Pastikan dapat ditelusuri untuk keperluan audit dan akreditasi.
11. Lakukan review berkala
 - a. Evaluasi perencanaan secara periodik (bulanan/triwulan).
 - b. Sesuaikan dengan perubahan jumlah pasien atau pola terapi.

5.2 Pengadaan Logistik

Pengadaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Mengacu pada sistem pengadaan pemerintah (e-catalogue atau distribusi dari Dinas Kesehatan/Kemenkes).
2. Khusus ARV, biasanya disuplai melalui program nasional HIV/AIDS.
3. Harus menjamin mutu, keamanan, dan legalitas produk.

5.3 Penerimaan dan Verifikasi

1. Persiapan penerimaan
 - a. Siapkan ruang penerimaan/logistik yang bersih, aman, dan sesuai standar penyimpanan.
 - b. Siapkan dokumen pendukung: surat jalan, surat pemesanan, dan dokumen pengadaan.
 - c. Siapkan formulir pemeriksaan/verifikasi logistik.
2. Penerimaan fisik logistik
 - a. Terima logistik dari pemasok atau distribusi program nasional.
 - b. Periksa kondisi fisik barang: kemasan utuh, tidak rusak, tidak basah, dan tidak terbuka.
 - c. Pastikan jumlah barang sesuai dokumen pengiriman.
3. Verifikasi dokumen

Cocokkan logistik dengan dokumen pengadaan

 - a. Jenis dan jumlah barang
 - b. Nomor batch/lot
 - c. Tanggal produksi dan kedaluwarsa
 - d. Sertifikat dan izin edar (BPOM) bila diperlukan
4. Pemeriksaan mutu dan kualitas
 - a. Periksa kondisi fisik obat ARV dan reagen laboratorium.
 - b. Pastikan tidak ada kerusakan pada kemasan.
 - c. Pastikan suhu dan kondisi khusus selama pengiriman terpenuhi (misal cold chain).
5. Pencatatan penerimaan
 - a. Catat semua logistik yang diterima dalam buku penerimaan/logistik atau sistem elektronik (SIHA/logistik farmasi).
 - b. Buat Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) sebagai bukti formal
6. Penanganan ketidaksesuaian

Jika terdapat ketidaksesuaian jumlah, jenis, atau kondisi barang:

 - a. Tolak sebagian atau seluruh barang.
 - b. Dokumentasikan ketidaksesuaian.
 - c. Laporkan ke pemasok atau program nasional.

5.4 Penyimpanan

1. Persyaratan penyimpanan
 - a. Gudang/logistik harus bersih, kering, berventilasi baik, dan memiliki kontrol suhu dan kelembaban.
 - b. Area penyimpanan dipisahkan menurut jenis logistik:
 - 1) ARV
 - 2) Reagen laboratorium
 - 3) Bahan habis pakai (BHP)
 - c. Barang ditempatkan tidak langsung di lantai, menggunakan rak/kotak penyimpanan.
 - d. Akses gudang hanya untuk petugas berwenang
2. Prosedur penyimpanan

- a. Penerimaan barang
 - 1) Barang diterima sesuai prosedur penerimaan dan verifikasi logistik.
 - 2) Pastikan barang sesuai pesanan, tidak rusak, dan memiliki dokumen lengkap
- b. Penataan barang
 - 1) Letakkan barang berdasarkan kategori dan tanggal kedaluwarsa.
 - 2) Terapkan sistem FIFO (First In First Out) atau FEFO (First Expired First Out).
 - 3) Pisahkan barang yang mendekati kadaluarsa agar digunakan lebih dulu
- c. Pengendalian suhu dan kondisi
 - 1) Monitor suhu dan kelembaban sesuai jenis logistik:
 - a) ARV: suhu ruang 20–25°C
 - b) Reagen khusus: cold chain 2–8°C
 - 2) Gunakan alat monitoring (thermometer/humidity logger) secara rutin.
- d. Pengelolaan stok
 - 1) Catat semua logistik yang masuk dan keluar secara manual atau elektronik (SIHA/logistik farmasi).
 - 2) Lakukan stock opname rutin untuk memeriksa kesesuaian fisik dengan catatan stok.
 - 3) Pastikan logistik yang digunakan tidak kadaluarsa dan sesuai indikasi terapi.

5.5 Distribusi dan Penyaluran

- 1. Permintaan logistik oleh unit pelayanan
 - a. Unit pelayanan mengajukan permintaan logistik menggunakan formulir permintaan barang atau sistem elektronik.
 - b. Permintaan harus mencantumkan:
 - 1) Jenis dan jumlah barang
 - 2) Tujuan penggunaan
 - 3) Periode kebutuhan
- 2. Verifikasi permintaan
 - a. Petugas instalasi farmasi/logistik melakukan verifikasi:
 - 1) Kesesuaian dengan kebutuhan riil
 - 2) Ketersediaan stok
 - 3) Pola penggunaan sebelumnya
 - b. Jika tidak sesuai, dilakukan klarifikasi dengan unit pemohon
- 3. Persiapan barang
 - a. Petugas menyiapkan logistik sesuai permintaan yang telah disetujui.
 - b. Terapkan prinsip:
 - 1) FEFO (First Expired First Out)
 - 2) FIFO (First In First Out)
 - c. Periksa kondisi barang sebelum didistribusikan (tidak rusak/kadaluarsa).
- 4. Penyaluran/ Distribusi
 - a. Distribusikan logistik ke unit tujuan sesuai jadwal atau kebutuhan.
 - b. Gunakan dokumen serah terima barang (bukti distribusi).
 - c. Pastikan pengiriman sesuai kondisi penyimpanan:
 - 1) Cold chain untuk reagen tertentu
 - 2) Keamanan untuk obat ARV
- 5. Penerimaan di unit pelayanan

- a. Unit penerima melakukan:
 - 1) Pemeriksaan jumlah dan kondisi barang
 - 2) Verifikasi kesesuaian dengan permintaan
- b. Menandatangani bukti penerimaan barang.

5.6 Penggunaan dan Pengendalian

1. Penggunaan obat (ARV dan obat infeksi oportunistik)
 - a. Gunakan obat sesuai pedoman terapi HIV/AIDS nasional.
 - b. Resep diberikan oleh dokter yang berwenang.
 - c. Pastikan:
 - 1) Identitas pasien sesuai
 - 2) Regimen ARV tepat
 - 3) Dosis dan durasi sesuai
 - d. Lakukan konseling kepatuhan (adherence) kepada pasien.
2. Penggunaan reagen dan alat kesehatan
 - a. Gunakan sesuai standar prosedur laboratorium.
 - b. Pastikan:
 - 1) Reagen belum kadaluarsa
 - 2) Kondisi penyimpanan sesuai
 - c. Catat setiap penggunaan dalam logbook laboratorium.
3. Penggunaan bahan habis pakai
 - a. Gunakan sesuai kebutuhan pelayanan.
 - b. Hindari penggunaan berlebihan.
 - c. Pastikan sesuai standar keselamatan pasien dan petugas
4. Pengendalian logistik
 - a. Pencatatan dan pelaporan
 - 1) Catat setiap penggunaan logistik dalam:
 - a) Buku stok/kartu stok
 - b) Sistem elektronik (SIHA/logistik farmasi)
 - 2) Laporkan penggunaan secara berkala (bulanan/triwulan).
 - b. Monitoring stok
 - 1) Tetapkan stok minimum dan maksimum.
 - 2) Pantau ketersediaan logistik secara rutin.
 - 3) Lakukan peringatan dini jika stok mendekati minimum.
 - c. Evaluasi penggunaan
 - 1) Bandingkan antara:
 - a) Perencanaan kebutuhan
 - b) Realisasi penggunaan
 - 2) Identifikasi:
 - a) Overuse (penggunaan berlebih)
 - b) Underuse (penggunaan kurang)
 - d. Pengendalian mutu
 - 1) Pastikan tidak ada penggunaan:
 - a) Obat/reagen kadaluarsa
 - b) Barang rusak
 - 2) Lakukan pelacakan berdasarkan nomor batch/lot jika terjadi masalah mutu
 - e. Pengendalian kehilangan dan penyalahgunaan
 - 1) Batasi akses logistik hanya untuk petugas berwenang.
 - 2) Lakukan audit internal secara berkala.
 - 3) Laporkan dan tindaklanjuti setiap kehilangan atau penyimpangan.

5.7 Pengelolaan Obat Kedaluwarsa dan Limbah

1. Identifikasi dan pemisahan
 - a. Identifikasi logistik yang:
 - 1) Kedaluwarsa
 - 2) Rusak
 - 3) Tidak memenuhi standar mutu
 - b. Pisahkan dari stok aktif dan beri label khusus (Tidak Layak Pakai).
 - c. Kelompokkan berdasarkan jenis:
 - 1) Obat
 - 2) Reagen
 - 3) Limbah medis infeksius
2. Pencatatan
 - a. Catat:
 - 1) Nama barang
 - 2) Jumlah
 - 3) Nomor batch/lot
 - 4) Tanggal kedaluwarsa
 - 5) Kondisi barang
 - b. Dokumentasikan untuk keperluan audit dan pelaporan.
3. Penyimpanan sementara
 - a. Simpan di area khusus limbah/logistik rusak yang terpisah dari stok aktif.
 - b. Gunakan wadah yang aman, tertutup, dan diberi label sesuai jenis limbah.
 - c. Pastikan keamanan dan mencegah akses tidak sah
4. Pengangkutan internal
 - a. Lakukan pengangkutan dari unit pelayanan ke tempat penyimpanan limbah dengan:
 - 1) Wadah tertutup
 - 2) Jalur khusus (jika tersedia)
 - b. Gunakan APD sesuai standar keselamatan kerja.
5. Pemusnahan
 - a. Lakukan pemusnahan sesuai jenis limbah:
 - 1) Obat dan BHP: dimusnahkan melalui insinerator atau pihak ketiga berizin
 - 2) Reagen dan limbah kimia: sesuai prosedur limbah B3
 - b. Dilakukan oleh pihak berwenang atau vendor berizin resmi.
 - c. Buat Berita Acara Pemusnahan.

BAB VI KESELAMATAN PASIEN

6.1 Ketentuan Umum

1. Rumah sakit menjamin keselamatan pasien dalam seluruh proses pelayanan HIV/AIDS.
2. Pelayanan diberikan secara aman, bermutu, non-diskriminatif, dan menjaga kerahasiaan pasien.
3. Seluruh tenaga kesehatan menerapkan prinsip keselamatan pasien sesuai standar akreditasi

6.2 Sasaran Keselamatan Pasien

1. Ketepatan Identifikasi Pasien
 - a. Menggunakan minimal dua identitas (nama dan tanggal lahir/nomor rekam medis).
 - b. Dilakukan pada setiap tindakan, pemberian ARV, dan pemeriksaan laboratorium.
2. Peningkatan Komunikasi Efektif
 - a. Menggunakan metode komunikasi standar (SBAR).
 - b. Hasil pemeriksaan kritis (CD4, viral load) disampaikan tepat waktu
3. Keamanan obat yang perlu diwasapadai (ARV)
 - a. Menerapkan prinsip 6 benar (pasien, obat, dosis, waktu, cara, dokumentasi).
 - b. Memastikan tidak terjadi interaksi obat.
 - c. Monitoring efek samping dan kepatuhan pasien
4. Kepastian tepat prosedur dan tepat pasien
 - a. Melakukan verifikasi sebelum tindakan medis.
 - b. Melaksanakan informed consent.
5. Pengurangan risiko infeksi
 - a. Menerapkan kewaspadaan standar (cuci tangan, APD).
 - b. Pengelolaan alat dan limbah medis sesuai prosedur.
 - c. Pencegahan infeksi nosokomial dan transmisi HIV.
6. Pencegahan risiko cedera (pasien jatuh)
 - a. Melakukan asesmen risiko jatuh.
 - b. Memberikan intervensi sesuai kondisi pasien

6.3 Penerapan Keselamatan dalam Pelayanan HIV/AIDS

1. Pelayanan klinis
 - a. Diagnosis dan terapi dilakukan sesuai pedoman nasional.
 - b. Pemberian ARV aman dan terpantau.
 - c. Pemantauan kondisi klinis secara berkala
2. Pelayanan penunjang
 - a. Pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai standar mutu dan keselamatan.
 - b. Penanganan spesimen mengikuti prosedur biosafety.
3. Pencegahan penularan
 - a. Edukasi pasien tentang pencegahan penularan HIV.
 - b. Penerapan universal precaution oleh tenaga kesehatan.

6.4 Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

1. Setiap insiden (KTD, KNC, KPC, sentinel) wajib dilaporkan.
2. Dilakukan analisis akar masalah (Root Cause Analysis).
3. Disusun rencana tindak lanjut dan perbaikan sistem

BAB VII

KESELAMATAN KERJA

7.1 Identifikasi Risiko Kerja

1. Risiko tertusuk jarum atau benda tajam (needle stick injury).
2. Paparan darah dan cairan tubuh yang berpotensi menularkan HIV.
3. Risiko infeksi akibat prosedur invasif dan penanganan spesimen.
4. Risiko psikososial seperti stigma dan beban kerja

7.2 Pencegahan dan Pengendalian Risiko

1. Penerapan kewaspadaan standar (Standar Precaution)
 - a. Cuci tangan sesuai 5 momen WHO.
 - b. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD): sarung tangan, masker, pelindung wajah, gaun.
 - c. Penanganan alat medis sesuai prinsip steril dan desinfeksi.
2. Pengelolaan alat tajam
 - a. Tidak melakukan recapping jarum.
 - b. Menggunakan safety box untuk pembuangan jarum.
 - c. Segera membuang alat tajam setelah digunakan.
3. Pengelolaan limbah medis
 - a. Pemilahan limbah infeksius sesuai warna dan jenis.
 - b. Pengangkutan dan pemusnahan limbah sesuai prosedur.
 - c. Menghindari kontak langsung tanpa APD
4. Pengendalian lingkungan kerja
 - a. Penyediaan fasilitas cuci tangan dan APD yang memadai.
 - b. Ventilasi ruangan yang baik.
 - c. Kebersihan dan sanitasi lingkungan

7.3 Penanganan Pajanan

1. Tindakan segera
 - a. Luka tusuk/tergores: cuci dengan air mengalir dan sabun tanpa ditekan.
 - b. Pajanan mukosa (mata/mulut): bilas dengan air bersih atau NaCl 0,9%.
 - c. Kulit tidak utuh: bersihkan dengan air dan sabun.
 - d. Tidak menggunakan bahan iritatif (alkohol/yodium pada luka terbuka)
2. Pelaporan kejadian
 - a. Segera laporkan ke atasan langsung atau Tim K3RS.
 - b. Isi formulir kejadian pajanan/kecelakaan kerja.
 - c. Pelaporan dilakukan secepatnya (ideal < 1 jam)
3. Penilaian risiko pajanan
 - a. Identifikasi jenis pajanan (tusukan jarum, percikan, dll).
 - b. Menilai jenis cairan (darah/cairan tubuh berisiko).
 - c. Menilai status HIV sumber pajanan (jika diketahui).
 - d. Menentukan tingkat risiko (rendah/sedang/tinggi)
4. Pemeriksaan awal (Baseline)
 - a. Pemeriksaan HIV pada petugas terpapar.
 - b. Pemeriksaan HIV pada sumber pajanan (dengan informed consent).
 - c. Pemeriksaan tambahan bila diperlukan (HBV, HCV)
5. Pemberian profilaksis pasca pajanan (PEP)
 - a. Diberikan segera, maksimal dalam 72 jam setelah pajanan.
 - b. Menggunakan regimen ARV sesuai pedoman nasional.
 - c. Lama terapi 28 hari.
 - d. Edukasi kepatuhan minum obat

6. Konseling
 - a. Konseling pra dan pasca pemeriksaan HIV.
 - b. Edukasi risiko penularan dan manfaat PEP.
 - c. Dukungan psikologis bagi petugas
7. Tindak Lanjut dan Monitoring
 - a. Pemantauan efek samping obat PEP.
 - b. Pemeriksaan ulang HIV pada:
 - 1) 6 minggu
 - 2) 3 bulan
 - 3) 6 bulan
 - c. Pemantauan kepatuhan terapi

7.4 Pelatihan dan Edukasi Petugas

1. Pelatihan rutin tentang K3, pencegahan infeksi, dan penanganan pajanan.
2. Edukasi penggunaan APD dan prosedur kerja aman.
3. Simulasi kejadian darurat terkait pajanan HIV

7.5 Pemeriksaan Kesehatan Petugas

1. Jenis pemeriksaan kesehatan
 - a. Pemeriksaan pra kerja
 - 1) Dilakukan sebelum petugas ditempatkan di unit pelayanan HIV/AIDS.
 - 2) Meliputi:
 - a) Anamnesis dan pemeriksaan fisik
 - b) Pemeriksaan laboratorium dasar
 - c) Skrining penyakit menular (termasuk HIV dengan persetujuan)
 - b. Pemeriksaan berkala
 - 1) Dilakukan secara rutin (minimal 1 kali/tahun atau sesuai risiko).
 - 2) Meliputi:
 - a) Evaluasi kesehatan umum
 - b) Pemeriksaan sesuai risiko kerja (HBV, HCV, dll)
 - c) Penilaian kelayakan kerja
 - c. Pemeriksaan khusus (pasca pajanan)
 - 1) Dilakukan setelah terjadi pajanan (needle stick injury, percikan cairan tubuh).
 - 2) Meliputi:
 - a) Pemeriksaan HIV baseline
 - b) Pemeriksaan lanjutan (6 minggu, 3 bulan, 6 bulan)
 - c) Pemantauan selama pemberian PEP
2. Pelaksanaan pemeriksaan
 - a. Dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten.
 - b. Mengacu pada standar pelayanan kesehatan kerja.
 - c. Dikoordinasikan oleh tim K3RS/Unit Kesehatan Kerja
3. Konseling dan edukasi
 - a. Konseling pra dan pasca tes HIV.
 - b. Edukasi tentang pencegahan penularan.
 - c. Dukungan psikologis bagi petugas, terutama setelah pajanan

BAB VIII

PENGENDALIAN MUTU

8.1 Indikator Mutu Pelayanan HIV/AIDS

Tabel 8.1.1 Indikator Mutu Pelayanan HIV/AIDS

No	Indikator	Stnadar	Ket
1	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien HIV	≥90%	TIM

8.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu

1. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP dan clinical pathway.
2. Menerapkan standar keselamatan pasien.
3. Menggunakan pedoman nasional HIV/AIDS dalam praktik klinis.
4. Melibatkan seluruh tim multidisiplin.

8.3 Pengumpulan dan Analisa Data

1. Mengumpulkan data indikator mutu secara rutin.
2. Melakukan analisis tren dan capaian kinerja.
3. Mengidentifikasi masalah dan penyebabnya.

8.4 Audit dan Evaluasi

1. Melakukan audit medis dan audit kepatuhan SOP.
2. Evaluasi berkala terhadap mutu pelayanan.
3. Melibatkan tim mutu/PMKP rumah sakit.

8.5 Tindak Lanjut Perbaikan

1. Menyusun rencana tindak lanjut (RTL) berdasarkan hasil evaluasi.
2. Melakukan perbaikan proses pelayanan.
3. Monitoring implementasi perbaikan.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Pelayanan HIV/AIDS di rumah sakit ini disusun sebagai acuan bagi seluruh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif, bermutu, aman, dan berkesinambungan kepada pasien. Pedoman ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta perlindungan bagi petugas kesehatan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan pedoman ini sangat bergantung pada komitmen, kerja sama, dan kepatuhan seluruh jajaran rumah sakit dalam menerapkan setiap ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan monitoring, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan agar pelayanan HIV/AIDS dapat berjalan secara optimal dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, diharapkan pedoman ini dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan HIV/AIDS yang profesional, berorientasi pada pasien, serta bebas dari stigma dan diskriminasi, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep